

RESUMEN:

La adquisición del lenguaje «comienza» antes de que el niño exprese su primer habla léxico-gramatical. El lenguaje va a posibilitar al niño la incorporación de los instrumentos simbólicos propios de su cultura y le va a permitir comunicarse no sólo con los demás sino también consigo mismo pues la interiorización del lenguaje está en la génesis del pensamiento. Cuando un bebé no dispone del sistema visual, tan importante para el establecimiento de la comunicación, pueden verse alteradas las formas de comunicación, tanto las no intencionales como las de carácter intencional. A pesar de que el bebé ciego posee un buen número de conductas alternativas que pueden vehiculizar su comunicación, es posible que el adulto no sea capaz de interpretarlas o adaptarse a ellas, y, por tanto, no pueda guiar la comunicación.

La ceguera condiciona el «diálogo» preverbal en el proceso de comunicación sobre el mundo externo. Recordemos que las pautas preverbales de carácter protodeclarativo y protoimperativo son incubadas en los gestos deícticos que poseen en su origen una gran saturación de componentes visuales. Desde luego, al adulto le resulta difícil interpretar los gestos sustitutivos para dirigir su atención hacia los objetos y compartir con el niño ciego su interés por los mismos.

ABSTRACT:

The acquisition of language "begins" before the child expresses his first lexical-grammatical speech. The language will enable the child to incorporate the symbolic instruments of his culture and will allow him to communicate not only with others but also with himself because the internalization of language is in the genesis of thought. When a baby does not have the visual system, so important for the establishment of communication, the forms of communication, both unintentional and intentional, may be altered. Although the blind baby has a good number of alternative behaviors that can convey their communication, the adult may not be able to interpret or adapt to them, and therefore cannot guide the communication.

Blindness determines preverbal "dialogue" in the process of communication about the external world. Recall that the preverbal guidelines of a protodeclarative and protoimperative nature are incubated in the deictic gestures that originally have a great saturation of visual components. Of course, it is difficult for adults to interpret substitute gestures to direct their attention to objects and share their interest in them with the blind child.

INDICE

INTRODUCCIÓN	
1. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL ESTUDIO DE CASO COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
1.1. Consideraciones generales de los estudios acerca del niño ciego y el desarrollo del lenguaje oral. Sus particularidades psicológicas	
2. REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL ESCOLAR CIEGO DE I CICLO	
2.1. El tratamiento logopédico para el niño ciego	
2.2. Estructura del estudio de caso	
2.3. Fundamentos generales que sustentan el sistema de tratamiento logopédico para el desarrollo del lenguaje en niño ciego del primer ciclo de la Escuela Especial "Abel Santamaría Cuadrado".	
2.4. Sistema de tratamientos logopédicos	
3. ESTUDIO DE CASO	
3.1. Resultados parciales de los instrumentos o pruebas seleccionados para la evaluación del escolar	
3.2. Sistema de actividades para el trabajo con la dislalia en el escolar con diagnóstico de ceguera	
CONCLUSIONES	
BIBLIOGRAFÍA	

INTRODUCCIÓN

La educación de educandos con baja visión y ciegos constituyen una prioridad para el gobierno cubano es por ello que el estudio del desarrollo psicológico en los niños que carecen de visión o que ésta es ineficaz como medio de información y de contacto con el entorno, presenta un claro interés en sí mismo. Pero este interés aumenta de forma ostensible en la medida que proporciona conocimientos óptimos para establecer pautas de intervención psicopedagógica en el desarrollo-aprendizaje de esta población.

Se tienen en cuenta el desarrollo del lenguaje oral en estos educandos al referirse como la capacidad para percibir y discriminar similitudes, así como para llegar a la formación de una imagen mental es un proceso esencialmente visual. Algunos autores mantienen que entre un 80-85% de las experiencias generadoras de aprendizaje tienen lugar a través de la visión.

Por otra parte, el desarrollo psicomotor temprano y la integración motora conducen al desarrollo cognitivo y a la expansión de las capacidades mentales en el educando. La exploración sensorial de los objetos deriva en la percepción de los mismos y más tarde en la percepción de los conceptos, en los que se basa el mundo abstracto.

Los conceptos se desarrollan a partir del proceso perceptivo y se enriquecen a medida que el educando evoluciona en su lenguaje. Por tanto, la amplitud de experiencias perceptivas determina, en gran medida, la amplitud del desarrollo intelectual.

El niño ciego se ve privado de una fuente valiosa para la recogida de información sensorial; la evolución de su desarrollo cognitivo va a ser más lenta y desigual que la de los educandos videntes.

Es por ello que se hace necesario trabajar en potenciar el desarrollo oral en estos educandos dado las limitaciones sensoriales del mundo que le rodea para así buscar las causas que provocan la situación real que manifiesta el educando que se estudia, porque a pesar de haber sido aplicado el diagnóstico con su carácter individual, multilateral, preventivo, retroalimentador, transformador, colaborativo, participativo, dinámico, continuo, sistemático, multidisciplinario e interdisciplinario, este sigue presentando problemas en la comunicación ya sea por causas orgánicas o funcionales como: poca

estimulación por parte de maestros y familiares, un modelo lingüístico inadecuado, insuficiente desarrollo en el área del lenguaje. Es por esto que esta investigación se propone como objetivo elaborar un sistema de tratamientos logopédicos para el desarrollo del lenguaje en el educando ciego del primer ciclo de la Escuela Especial "Abel Santamaría Cuadrado" de Marianao.

DESARROLLO

1.1. Consideraciones generales acerca del estudio de caso como método de investigación científica

El estudio de caso constituye el método cualitativo por excelencia en el proceso de diagnóstico. Por eso, desde que se realizan las primeras exploraciones en el educando y su entorno educativo más cercano: la escuela, la familia y la comunidad; se sigue la evolución durante el proceso de evaluación, caracterización y diagnóstico logopédico, lo que depende de que su pronóstico sea más favorable o no, por el hecho de considerar el papel decisivo de los mediadores para potenciar su desarrollo y favorecer una educación cada vez más inclusiva.

Se elabora la estrategia de intervención que contribuye al pleno desarrollo de sus capacidades y auxiliarse de métodos de investigación teóricos y empíricos como: observación de actividades, exploración logopédica, pruebas pedagógicas y psicológicas, análisis documental de expedientes, entrevista a especialistas, análisis y síntesis de la información recopilada para arribar al diagnóstico y modelación del diseño de la estrategia de intervención logopédica así como el sistema de tratamiento como las orientaciones a padres y maestros sobre cómo corregir y/o compensar el trastorno del nivel comunicativo habla(dislalia funcional) de un niño de 4to grado de la Escuela Especial "Abel Santamaría Cuadrado" de educandos ciegos y baja visión.

Se asume la metodología que se aplica con más frecuencia en el contexto de la Educación Especial, basada en investigaciones realizadas por las autoras C. Álvarez y S. Akudovich (2006), aunque se sugiere también la lectura complementaria del texto sobre el estudio de casos en la escuela, donde se presentan ideas acerca de su empleo como "método científico de investigación".

Los métodos teóricos y empíricos utilizados fueron:

Del nivel teórico

- Analítico-sintético: Para el estudio de los referentes teóricos que sustenta el desarrollo del lenguaje en educandos ciegos.
- Inductivo-deductivo: Para llegar por vía lógicas del pensamiento racional a una determinación conceptual del caso estudio
- Modelación: Para la consecución del sistema de tratamientos a desarrollar para el educando ciego del primer ciclo de la escuela especial para el desarrollo del lenguaje oral.

Del nivel empírico

- Análisis documental: Documentos normativos que rigen la educación especial de niños con trastornos sensoriales.
- Exploración logopédica: Para conocer las afectaciones en el lenguaje del educando estudio.
- Observación: Con el objetivo de observar su conducta y modos de actuación en el contexto social y educativo.
- Entrevista: A educadores, padres y demás agentes y agencias sociales y educativas y comunitarias que intervienen en la comunicación y formación de la personalidad del educando estudio.
- Técnicas psicológicas: Los 10 deseos, 3 roñas, completamiento de frases, cuarto excluido con la finalidad de explorar los estados psicológicos que presenta el niño estudio poder precisar su intervención logopédica.

1.1.2 Fundamentación teórica de la dislalia como trastorno del nivel comunicativo habla.

El lenguaje es un hecho social tanto por su origen como por su naturaleza, la psicología materialista dialéctica, explica la asimilación del lenguaje como medio de intercambio de ideas y de cognición con lo que nos rodea, es un sistema de signos, a través del mismo, mediante la lengua se establece el proceso de comunicación. La lengua es lo social, que tiene una función idiomática, mientras que el lenguaje es lo individual, la lengua garantiza la posibilidad de existencia del lenguaje y este último provee a la primera de los significados de las palabras.

Desde el punto de vista ontogenético, el lenguaje se desarrolla a través de una serie de etapas sucesivas cronológicamente, que constituyen un complejo proceso socio fisiológico de adquisición, que evoluciona paralelamente al desarrollo físico y motor del niño, debido entre otros factores a la maduración del sistema nervioso central, entre otras causas (Comas, R. 1979).

El desarrollo del lenguaje en el niño puede darse con diferentes ritmos de evolución. No todos los niños empiezan a la misma edad ni coinciden en el momento de finalizar el proceso (Ochoa, L. 2006).

Por el valor que posee el lenguaje para el desarrollo cognitivo, comunicativo, y la formación de la personalidad en general, exige que se enfatice aún más en su estimulación y desarrollo desde la educación infantil para prevenir los trastornos del lenguaje.

Estos son alteraciones que se presentan en el lenguaje y dificultan, de manera más o menos persistente, la comunicación lingüística, afectando no solo a aspectos lingüísticos (fonológicos, sintácticos o semánticos, tanto en el nivel de comprensión y decodificación como de expresión o producción-codificación), sino también intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las relaciones y rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados.

El concepto de dislalia proviene del latín dis: dificultad y lalien: hablar. Se utiliza para nombrar aquellos trastornos de pronunciación que se presentan sin otra manifestación acompañante, y en presencia de una audición normal. (Figueredo, 1984) [...] en correspondencia a las formas de aparición, modos y actitud del hablante y los otros, responde al trastorno en la articulación de los fonemas o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por la sustitución de estos por otros de forma impropia. Se trata pues de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. (Citado por G. P. Pascual, 1995)

En la sistematización del término autores como Uribe, Arana Chacón y Lorenzana Pombo (2002) la definen como “alteraciones de los rasgos fonológicos observados en la evaluación del habla actualizada durante el desarrollo del lenguaje”. (Citado por Uribe & Pombo, 2002)

Moreno. E. (2004) indica que son numerosos los acontecimientos que pueden repercutir en el lenguaje infantil. Padecer un trastorno como la dislalia puede provocar dificultad en un niño para interactuar con otro, una baja autoestima, dificultad escolar, rechazo o burla por parte de sus mismos compañeros, falta de aceptación personal, conflictividad, frustración, aislamiento, timidez, reducción del contacto con otras personas o sentido de inferioridad.

Otros como “un trastorno de articulación de la palabra que puede estar asociada a otros problemas del habla como la omisión de sonidos y algunas alteraciones de la sílaba”. Plantean que este trastorno es hasta cuatro veces más frecuente en el sexo masculino, presentándose con mayor frecuencia en la infancia, y puede ser pasajero o en ocasiones permanente. (Jiménez& Obispo, 2006) ;(G. Pascual, 2007).

Es por ello que entre sus antecedentes encontramos autores que han incursionado en el término en función del contexto, modalidad de atención y situaciones problemáticas sociales con implicación en el lenguaje y la comunicación desde edades tempranas, se desatacan desde el siglo pasado. (P. Pascual, 1981); (E. Figueredo, 1986); (X. F. Rodríguez, 1993); (Sos & Ma., 1997); Fernández, Pérez de Alejo. G. (2011), Arredondo Kassab.MM. (2004), entre otros, los cuales plantean que la dislalia constituye una alteración en los fonemas del idioma que dificulta la pronunciación en diferentes situaciones comunicativas. Cuando el lenguaje oral se encuentra muy afectado por la implicación de varios fonemas, puede llegar a ser ininteligible, con marcado énfasis en las relaciones sociales y de complejidades en su aparición multifactorial entre ellos el uso inadecuado de las Tics, lo cual concuerdo y asumo.

De lo anterior, los estudios realizados demuestran que, hasta los cinco años, la mayoría de los problemas de esta índole, son consecuencia de un proceso natural de adquisición lingüística y, pasado el período evolutivo correspondiente, casi todos desaparecen sin que sea necesaria la intervención de ningún profesional. Pero en algunos casos estas dificultades se deben a un mal funcionamiento de los órganos que intervienen en el habla, sobre todo por posiciones incorrectas de labios o lengua, incorrecta respiración, falta de aire, escasa movilidad de labios, lengua, paladar. Si estos patrones articulatorios persisten pueden llegar a automatizarse y, por lo tanto, ser más difíciles de corregir. Por esto, es tan importante una intervención temprana. (González & Villegas, 2012)

Se concuerda que es un trastorno en la articulación de los fonemas o grupos de fonemas causado por alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla (lengua, labios, paladar, mejillas y dientes). Puede afectar a cualquier

consonante o vocal y son muy frecuentes en la infancia, sobre todo en los primeros años escolares. De todas formas, con una adecuada intervención la mayoría de ellas desaparecen (E. C. Rodríguez, 2010).

Para Eduardo Pérez Expósito “la dislalia viene causada porque el niño no ha adquirido de forma correcta los patrones de movimiento que son necesarios para la producción de algunos sonidos del habla”. En otras palabras, el niño con este problema no mueve de forma correcta los músculos que se encargan del habla y por ellos comete omisiones, sustituciones y distorsiones de algunos sonidos de la lengua.(Pérez, 2016)

Los padres y madres comienzan a preocuparse cuando sus hijos no pronuncian correctamente algunas palabras, sobre todo cuando detectan que otros niños/as de su misma edad sí lo hacen. (González & Villegas, 2012)

Debido a lo planteado por los diversos autores y sus diferentes definiciones sobre la dislalia, la autora ha llegado a la conclusión que la mayor parte de ellos coinciden en que es un trastorno en la articulación y/o pronunciación de algunas palabras o grupos de fonemas producido por alteraciones de los órganos periféricos del habla, órgano fonatorios en posición incorrecta o daños en los distintos componentes (labios, lengua, paladar) de la boca y no por defecto del sistema nervioso central.

La dislalia se considera un trastorno del habla donde se altera el componente articulatorio por diferentes causas. Existen diferentes criterios de clasificación de la dislalia, ellos son:

- Por su etiología: Dislalia funcional, orgánica, audiógena.
- Por la diversidad de sonidos alterados: simples o monomorfos, complejos o polimorfos.
- Por la forma en que se alteran los sonidos: omisión, distorsión, sustitución, inserción y/o adición.
- Por el modo y nivel de alteración en la articulación de los sonidos.

La dislalia funcional es el trastorno que será abordado en esta investigación, los autores Moreno-González y Ramírez-Villegas (2012) plantean que es una alteración de los órganos sin ningún tipo de causa que los justifique. Se

caracteriza por las alteraciones en el funcionamiento de los órganos periféricos del habla que dificultan la pronunciación por la sustitución, distorsión, omisión e inserción de fonemas en las distintas posiciones en la palabra (inicial, media y final).

Este trastorno surge como consecuencia del debilitamiento de los procesos neurodinámicos superiores (excitación e inhibición). La persona con dislalia sabe que articula mal, quiere corregirse y trata de imitar al logopeda u otra persona que le corrige, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que el individuo desea. Hay que considerar que la emisión del fonema es el resultado final de la acción de la respiración, la fonación y la articulación (trabajo con el componente sonoro del lenguaje).

En las dislalias es necesario distinguir las formas en que se altera la pronunciación de los sonidos del idioma y/o los errores en la pronunciación. Ambos casos son válidos para precisar las alteraciones en la pronunciación de los sonidos por omisión, sustitución, distorsión, adición, transposición. La distorsión se presenta en aquellos sonidos distorsionados, aproximados e indefinidos, es la falta de claridad o descuido que da origen a un sonido débil o incompleto. (Rodríguez & Fernández, 2012).

Uno de los problemas del habla más comunes que se encuentran los logopedas al trabajar con niños son las dislalias funcionales de múltiples sonidos entre ellos (s, r,) que es el caso estudio.

1.1 Consideraciones generales de los estudios acerca del niño ciego y el desarrollo del lenguaje oral. Sus particularidades psicológicas

La educación de los niños y niñas en Cuba constituye una prioridad del sistema educativo cubano que, desde el triunfo de la Revolución hasta nuestros días, los escolares ciegos no han quedado exentos de esta atención teniendo como fin fundamental el que sus egresados puedan acceder a niveles superiores de desarrollo y lograr una adecuada incorporación a la vida social y laboral.

La comunicación en educandos con discapacidad es una prioridad para el sistema educativo cubano, es por ello que debe prevalecer el criterio de que la

ceguera condiciona el «diálogo» preverbal en el proceso de comunicación sobre el mundo externo. Recordemos que las pautas preverbales de carácter protodeclarativo y protoimperativo son incubadas en los gestos deícticos que poseen en su origen una gran saturación de componentes visuales. Desde luego, al adulto le resulta difícil interpretar los gestos sustitutivos para dirigir su atención hacia los objetos y compartir con el niño ciego su interés por los mismos.

Es por ello que, en el desarrollo psicológico del niño ciego, si, además, se añade su desfase en la adquisición de un mundo de objetos permanentes, le resultan comprensibles las dificultades para introducir objetos en los «diálogos» preverbales y en el desarrollo de iniciativas propias en el juego con objetos (aspectos ambos tan necesarios para la simbolización).

No obstante, y como se evidencia, si los adultos que rodean al niño aprenden a comprender sus señales comunicativas es posible que el bebé ciego pueda establecer su sistema de comunicación preverbal basándose en experiencias auditivas y táctiles, aunque la iniciativa, en estas primeras etapas, tenga que partir siempre de los adultos.

Por lo que la adquisición del lenguaje oral, hacia los doce meses aproximadamente, los niños empiezan a expresar sus intenciones comunicativas a través de las palabras.

Este comienzo es, durante los primeros meses, lento y paulatino, pero a partir de los 18-24 meses, se convierte en uno de los fenómenos más espectaculares del desarrollo infantil. El vocabulario aumenta rápidamente y las combinaciones de palabras son cada vez más complejas y elaboradas.

Metodológicamente, dada la dificultad para abordar simultáneamente todos los aspectos involucrados, diferenciaremos forma, contenido y usos del lenguaje, entendiendo que el total es siempre más que la suma de sus partes, teniendo en cuenta los: aspectos formales: fonología y morfosintaxis, los aspectos de contenido: léxico y semántica y los aspectos de uso: función comunicativa o pragmática.

En el educando ciego en su desarrollo psicológico se destaca:

Etapas relevantes del desarrollo fonológico

- **6 meses** Vocalizaciones no lingüísticas relacionadas con hambre, dolor, placer.
- **6- 9 meses** Vocalizaciones no lingüísticas: gorjeos... que pueden formar parte de la proto- conversaciones con el adulto.
- **9- 18 meses** Balbuceo constante, curvas de entonación, ritmo y tono de voz variado y aparentemente lingüístico.
- **18 meses- 6 años** Posible aparición de segmentos de vocalización que aparecen corresponder a las palabras.

Construcción del sistema fonológico. Puesta en marcha de "procesos" fonológicos:

- Sustitución.
- Asimilación.
- Simplificación de la estructura fonológica.

En lo léxico y semántico se aprecia que la adquisición del significado y el papel que éste desempeña en el lenguaje es un tema extremadamente complejo. Las razones estriban en las dificultades inherentes al estudio del significado en sí.

Si intentamos abordar el desarrollo semántico, nos encontramos con una doble vía de acceso: por una parte, el niño adquiere los aspectos semánticos de las estructuras sintácticas, pero por otra, también aprende el significado que las palabras tienen de forma individual. Este último aspecto constituye el desarrollo del léxico.

Esta diferenciación, muy clara a partir de cierta edad, es muy difícil de establecer en las primeras fases de adquisición del lenguaje, pues en ellas léxico y sintaxis parecen estar estrechamente ligados. Así, el niño extraería del flujo lingüístico del entorno <<unidades>> con significado. Dichas unidades pueden estar constituidas por una sola palabra o bien por expresiones más amplias (tomadas como una sola palabra o unidad) que sólo en un nivel más evolucionado podría llegar a segmentar y analizar.

Las primeras palabras que emite el niño se refieren a objetos de su espacio próximo. Nelson (1973), en un estudio sobre las primeras palabras emitidas por un grupo de niños, encontró que las categorías más frecuentes se referían a comida, ropa, personas familiares, juguetes, objetos domésticos, animales y

vehículos. Pero sus significados no se corresponden exactamente con los del adulto, pues utiliza sobre extensiones (etiquetar con una palabra más referentes que los que posee en el código adulto; Ej. utilizar el término "guau-guau" no sólo para los perros, sino para cualquier animal de cuatro patas) y/o sobre discriminaciones (utilizar una palabra con referencias más restrictivas que las consideradas en el lenguaje adulto; Ej. utilizar el término "guau-guau" sólo para hacer referencia a su propio perro).

Para Clark (1973) las sobreextensiones están construidas sobre atributos perceptivos (tamaño, forma, sonido, movimiento, gusto y textura), sin embargo Nelson (1974), desde una perspectiva piagetiana, considera que son variables de tipo funcional (usos y acciones) las que están en la base de su desarrollo y otros autores (Bowerman, 1978) señala que surgen a través de "prototipos" de la categoría semántica a adquirir (ej. Será más fácil que el niño considere como referente de la palabra «pájaro» a un canario, que a un pingüino). Mulford (1988) publicó una revisión de las investigaciones más relevantes, en el proceso de adquisición del léxico, en el caso de los niños ciegos. Además de no apreciar retraso en la edad de emisión de las primeras palabras (14,7 meses), comparando sus datos con los obtenidos por Nelson (1973) en niños videntes, encontró algunas diferencias importantes: Los niños privados de visión utilizaban más nombres específicos y de palabras de acción, menor número de nombres generales y prácticamente ninguna palabra función. Nuestra práctica diaria corrobora estos datos, habiendo observado además que los niños ciegos utilizan sólo sobre discriminaciones y nunca sobreextensiones. Estas diferencias podrían explicarse desde el escaso conocimiento que poseen de los objetos y de las cosas, lo que disminuye la posibilidad de formar categorías mediante generalización.

En las categorías semánticas de Nelson referidas a objetos domésticos y muebles, así como a animales, también aparecían diferencias significativas entre los niños ciegos y los videntes, mientras que en el resto de categorías las diferencias entre los dos grupos eran irrelevantes. Está claro que sobre estas diferencias influye la posibilidad o no de experiencia directa del niño sobre los objetos o animales. En otras categorías, como la relativa a palabras de acción, los niños ciegos emiten mayor número de palabras referidas a acciones, si bien

es cierto que tales términos se referían a acciones propias y a deseos-demandas.

Esta peculiaridad ha llevado a algunos autores a calificar el lenguaje del niño ciego como «egocéntrico», término muy discutible si tenemos en cuenta simplemente el hecho de que es imposible hablar de las acciones ajenas cuando no se pueden percibir.

Es por ello que se asume [...] *el lenguaje del niño con impedimento visual se centra más en sí mismo y no se orienta, al comienzo, hacia el medio o hacia experiencias que le son ajenas...* Dado por (Andersen, Denlea, 1984). En muchas ocasiones, es cierto que los niños ciegos utilizan palabras cuyo significado desconocen produciéndose el fenómeno denominado "verbalismo", cuya emisión tiene unas características especiales.

En nuestras observaciones de niños ciegos comprobamos que la utilización de los términos <<verbalistas>> no es inadecuada; los niños utilizan determinadas palabras en contextos apropiados, pero desconocen su significado lexical. Parece como si, en el proceso de diferenciación léxico-semántico, (al que se aludió en el principio de este apartado) se mantuviera en la significación de unidades amplias, favorecidas por el uso contextual, pero que no diera el paso o tardara mucho más en darlo, hacia la segmentación y el análisis individual de algunas palabras.

En la función comunicativa o pragmática, el desarrollo de los aspectos formales y significativos del lenguaje va íntimamente ligado a la función comunicativa que expresan.

Diferentes investigadores (Halliday, 1975; Dore, 1974-1979; Bates, 1976) han realizado estudios sobre los usos funcionales de la comunicación, tanto en las etapas lingüísticas como en las prelingüísticas. Todos coinciden en afirmar que el lenguaje evoluciona desde una base pragmática. Pero si bien es cierto que la intención comunicativa sería previa a la utilización de estructuras, no menos cierto es que sin un desarrollo formal, las funciones comunicativas tienden a anquilosarse. Los diversos autores han propuesto a su vez diferentes modelos de las funciones comunicativas y su desarrollo, pero hay en toda una coincidencia en destacar, como más importantes, las siguientes:

- Función reguladora: con ella se trata de controlar la conducta del interlocutor. La expresión de deseos, la demanda de atención y la

ejecución de una conducta concreta por parte del otro serían ejemplos de esta función.

- Función declarativa o informativa: su objetivo es transmitir y compartir la información. Identificar objetos, describir sucesos, informar acerca de emociones, explicar razones, causas o justificaciones pertenecerían a esta función.
- Función interrogativa o heurística: a través de esta función se pretende investigar sobre la realidad, dirigiéndose al interlocutor para buscar información. Entre otras funciones comunicativas, cabe mencionar la instrumental, la interactiva, la personal y la imaginativa. La función reguladora es la primera que aparece en el desarrollo del niño, seguida de la función declarativa. Sus preludios son los protoimperativos y los protodeclarativos de la fase preverbal. En su investigación sobre la realidad a través del lenguaje, el niño llega a la edad de dos años con las funciones comunicativas más importantes ya adquiridas. A partir de entonces sus producciones son cada vez más ricas, más matizadas y sobre todo más plurifuncionales.

Las adquisiciones de las funciones comunicativas de los niños ciegos son detalladas por Rosa y Ochaita (1993) en referencia a las investigaciones de Duniea (1982) y Urwin (1984). Estas autoras relacionan la funcionalidad de las emisiones entre niños ciegos y videntes encontrando que:

- a) No se registran diferencias, en intención comunicativa, entre los dos grupos.
- b) Los niños ciegos, a medida que avanza su desarrollo lingüístico, utilizan el lenguaje de forma no interactiva en mayor proporción que los videntes, siendo habituales las repeticiones de palabras y frases escuchadas con anterioridad.
- c) La categoría <<peticiones>> así como la de «identificaciones/descripciones» son similares en ambos grupos.
- d) La categoría "llamar la atención" fue utilizada preferencialmente por los niños ciegos, mientras que las de «dirigir la atención» y "ofrecer-mostrar" fueron exclusivas de los niños videntes. Resulta obvio pensar en la necesidad de información visual para estas funciones declarativas e imperativas.

Desde esta interpretación, las imitaciones, repeticiones y rutinas cumplirían una función de andamiaje en el desarrollo de la propia lengua: los niños ciegos tomarían una frase aprendida por imitación y sobre ella practicarían modificaciones gramaticales y pragmáticas, a través de la variación de un solo elemento. Sería interesante comprobar, en etapas posteriores de la evolución lingüística, la validez de los significados de algunas de estas palabras analizadas de forma individual.

Parece relevante que, esta problemática del niño ciego, traduce una directa repercusión sobre el lenguaje del complejo entramado que tiene lugar en su proceso de diferenciación del "yo" y en la formación de un mundo externo de objetos permanentes.

Se hace evidente, una intervención pertinente por parte de los padres, en tanto *mediadores* entre el niño y el mundo de los objetos y *facilitadores* de la reversibilidad de roles a través del juego, colocará al niño en situación de lograr interacciones productivas de carácter lingüístico y no lingüístico; a partir de su desarrollo en instituciones especializadas en discapacidades sensoriales.

1.1.3 Breve caracterización de la escuela "Abel Santamaría Cuadrado".

La escuela "Abel Santamaría Cuadrado" está ubicada en el municipio Marianao. Está compuesta por un total de 30 trabajadores, Tiene una matrícula de 116 estudiantes, de ellos 37 son hembras y 79 varones, 8 de nuevos ingresos, 108 continuantes, 43 con retraso mental leve, 60 con retraso mental moderado, 10 con retraso mental severo y 3 con retraso mental profundo, con edades entre 6 y 20 años. La matrícula del centro por grados es la siguiente: en el 1er ciclo; primer grado tiene 6 escolares, 2do grado lo integran 10 alumnos, 4to grado está compuesto por 13 estudiantes; en el 2do ciclo, 5to grado posee 5 educandos, el grupo de 6to A 8 al igual que el de 6to B; en el 3er ciclo, el grupo de 7mo A lo componen 8 al igual que el de 7mo B, 8vo grado con 15 y 9no grado con 17; por otra parte, en el 4to ciclo hay 7 estudiantes.

1.2 Estructura del estudio de caso

Nombre y Apellidos: AMR.

Escuela Especial: "Abel Santamaría Cuadrado".

Dirección particular: Calle 232/23 A y 25, La Lisa, La Habana

Grado: 4to (1er ciclo).

Fecha de nacimiento: 25-1-02.

Edad: 9 años.

Motivo de selección del caso:

Escolar ciego que presenta una dislalia de causa funcional.

- **Caracterización psicopedagógica:**

Escolar con buena apariencia personal. Presenta ceguera. Talla en correspondencia con su edad, no así el peso, es obeso. Presenta buena asistencia al centro. Se comunica en forma oracional, establece conversaciones sobre temas variados. Hace preguntas. Es sociable, cariñoso, cooperador, pero voluntarioso. Establece relaciones adecuadas con coetáneos y adultos, aunque en ocasiones no tolera sus impulsos y responde de forma agresiva. Estado emocional inestable, bajo tolerancia ante las frustraciones. Comprende las órdenes. Realiza todas las tareas.

Estilo de aprendizaje independiente. Participa en todas las clases. En Lengua Española lee textos, responde preguntas de primero, segundo y tercer nivel sin ayuda. Reconoce elementos gramaticales del grado. Redacta textos acordes a su grado. En Matemática lee y escribe los números. Adiciona, sustrae y multiplica sin apoyo de materiales. Identifica los cuerpos geométricos. Resuelve problemas sencillos. Autovalidismo en correspondencia a su edad cronológica y su discapacidad. Cuida de sus pertenencias. Come solo, tiene control de esfínter. Participa en actividades recreativas con entusiasmo. En los talleres socializa con sus compañeros, le gusta participar de las preguntas y juegos que se realizan, se empeña en lograr correctamente su trabajo, le gusta mandar incluso a los profesores, no le gusta compartir muchas veces los recursos que se usan para trabajar, en general no tiene muy buena conducta. No cumple encomiendas en el hogar. Actualmente los padres están casados, pero la preocupación es buena. La madre es ama de casa, el padre es trabajador por cuenta propia. La conducta de ambos es buena. La madre asiste a la escuela con frecuencia. El estilo de educación que predomina es la sobreprotección. Su nivel de funcionamiento es alto.

1.3 Fundamentos generales que sustentan el sistema de tratamiento logopédico para el desarrollo del lenguaje en niño ciego del primer ciclo de la Escuela Especial "Abel Santamaría Cuadrado".

Desde el enfoque histórico cultural, el sistema de tratamientos logopédicos propuesto, se sustenta en los fundamentos siguientes:

Desde una mirada de la Concepción Dialéctica Materialista sobre el surgimiento de la conciencia, *como forma superior propia del ser humano, y reflejo de la realidad objetiva*¹. Esta surge en relación con el trabajo del hombre, con su actividad en la esfera de la producción social, y se halla indisolublemente vinculada a la aparición del lenguaje elemento esencial para su surgimiento.².

Un elemento determinante es la *unidad de lo cognitivo y lo afectivo esencia del desarrollo de los procesos psicológicos superiores y de la personalidad como un sistema*³; donde la creación de un clima emocional afectivo favorable en el trabajo con los niños constituye una condición imprescindible para contribuir a su desarrollo psíquico, que se sustenta en el sistema de tratamientos logopédicos, donde se tiene en cuenta el proceso enseñanza aprendizaje, como estructuración metodológica que adecua objetivos, contenidos, métodos, procedimientos, ejes temáticos, material verbal, forma de organización y evaluación, desde un enfoque preventivo, correctivo y/o compensatorio centrado en el retraso del lenguaje que presentan los niños; en relación con lo comunicativo-cognitivo y sociocultural. El autovalidismo, el interés y las motivaciones contenidas en dichos niños son elementos esenciales para que se pueda llevar a cabo la propuesta, *debido a que favorece las relaciones personales, la ayuda mutua y el respeto hacia la personalidad de sus iguales y la suya propia*.⁴ Además, se respetan los derechos a los que están sometidos, elemento a tener en cuenta por el logopeda. Constituyen fundamentos teóricos los referentes sistematizados en el Capítulo I.

¹Colectivo de autores: compendio. *Lecciones de filosofía Marxista-Leninista*. Dirección de Marxismo-Leninismo. Ministerio de Educación Superior, p. 50.

²Colectivo de autores: compendio. *Lecciones de filosofía Marxista-Leninista*. Dirección de Marxismo-Leninismo. Ob.cit., p 54

³ Ibídem, pp. 4-5.

⁴ Fernández Pérez de Alejo, Gudelia, Rodríguez Fleitas, Xiomara: Ob.cit., p. 32.

1.5. Sistema de Tratamientos Logopédicos.

En la sistematización del término el Diccionario Larousse Ilustrado, plantea que un sistema, es un (...) *conjunto de principios verdaderos o falsos reunidos entre sí, de modo que formen un cuerpo de doctrina. Combinación de partes reunidas para obtener un resultado o formar un conjunto. Modo de organización.*

El sistema término dado por Wikipedia plantea que... conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad...

La autora Consuegra Anaya, Natalia, en su diccionario psicológico, determina que es (...) *un conjunto de elementos en interacción dinámica en el que el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo configuran. Un sistema se compone de subsistemas entre los que existen límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del sistema y facilitar la integración de sus miembros en él.*⁵

Otros autores entre ellos Ferrater Mora en su diccionario filosófico, da como definición de sistema, a (...) *un conjunto de elementos relacionados entre sí y armónicamente conjugados.*⁶

Es por ello que se asume como sistema de tratamientos logopédicos (...) *un sistema en el que cada uno de sus componentes se vincula orgánicamente en función del objetivo general y, a su vez, se respetan las peculiaridades específicas de cada uno, lo que debe cumplirse para el éxito de dicha atención.*⁷

La comunicación es condición indispensable para la existencia, la vida material, la supervivencia, la vida espiritual y su enriquecimiento. La actividad comunicativa constituye un tipo de actividad espiritual producto de la cual se transmite o intercambia información y se desarrollan las relaciones sociales. La teoría de la actividad que nos establece la interrelación entre actividad práctica e ideal nos permite comprender cómo la conciencia se desarrolla determinada

⁵ Natalia Consuegra Anaya: *Diccionario de Psicología*. Ecoe Ediciones. Segunda Edición, Bogotá, 2010. p. 248.

⁶ José Ferrater Mora: *Diccionario de Filosofía*. Editorial Sudamericana Buenos Aires. p. 687.

⁷ Fernández Pérez de Alejo, Gudelia, Rodríguez Fleitas, Xiomara. Ob.cit, p. 56.

por la práctica o actividad material; por tanto, la actividad comunicativa constituye un elemento de gran importancia en la atención logopédica al niño con ceguera.

El desarrollo del lenguaje se manifiesta a través de una serie de etapas sucesivas cronológicamente, que constituyen un complejo proceso sociofisiológico de adquisición, que evoluciona paralelamente al desarrollo físico y motor del niño, gracias entre otros factores a la maduración del Sistema Nervioso Central. En él intervienen diferentes áreas de la corteza cerebral, pero hay dos que tienen particular importancia: el área de Wernicke y el área de Broca, las cuales están relacionadas con los dos aspectos esenciales de la comunicación: el aspecto sensorial y el aspecto motor, este último es el encargado de la producción del lenguaje, que implica el habla (articulación de los sonidos) y su control. El área de comprensión del lenguaje, denominada área de Wernicke, es la región más importante del cerebro para todas las funciones intelectuales superiores debido a que casi todas se relacionan con el lenguaje. Una región especial de la corteza frontal es el área de Broca, la cual proporciona los circuitos neurales para la formación de palabras. Es en esta área donde se inician y ejecutan los planes y patrones motores de la expresión de palabras aisladas y de frases cortas y funciona en estrecha relación con el área de Wernicke.

En el caso de un niño con ceguera su sistema sensorial visual está afectado por lo que la interacción del mundo que lo rodea se aprecia con deficiencia, son las relaciones de comunicación que establece el individuo con el medio social, mediante las actividades que realiza, las determinantes para promover el desarrollo, agravando o no la discapacidad que presentan.

El lenguaje constituye una de las manifestaciones esenciales de la vida psíquica del hombre y es además una propiedad distintiva del ser humano. Gracias a la palabra tiene lugar el desarrollo de procesos psíquicos como la percepción, la memoria y el pensamiento, además de propiciar la regulación compleja de las acciones. En este caso del menor presenta trastorno del lenguaje del nivel comunicativo habla, enmarcado en una dislalia funcional.

Un elemento importante dentro de la estrategia de intervención logopédica que se propone para un escolar de 4to grado con diagnóstico de dislalia funcional es la unidad de la instrucción, la educación y el desarrollo de la personalidad en el proceso docente educativo, porque las actividades que se proponen como parte de la estrategia incluyen la integración de los contenidos que el escolar recibe durante el tratamiento logopédico. Por eso, en la medida de que el niño desarrolle un sistema de comunicación adecuado en la escuela, estará en mejores condiciones para individualizar los conocimientos que recibe al experimentar un desarrollo consistente en toda su individualidad.

Durante la planificación del tratamiento logopédico en el estudio de caso de un escolar con diagnóstico dislalia funcional hay que tener en cuenta sus características logopédicas y psicopedagógicas. El sistema está estructurado por 10 tratamientos relacionados entre sí los cuales evidencian el contenido dirigido a potenciar el desarrollo del lenguaje del caso estudio.

El tratamiento logopédico está dividido en tres momentos fundamentales: introducción, desarrollo y conclusiones. En el primer momento se orientará el objetivo de la actividad, que es el componente rector del proceso de enseñanza aprendizaje, luego se pasa a la motivación inicial y después a la creación de las condiciones básicas para el comienzo de la misma.

En el desarrollo van a estar presentes el contenido, el cual debe ser objeto de asimilación en el aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos; los métodos, que son la forma de desarrollar el proceso docente educativo para alcanzar el objetivo; los procedimientos, que son subsistemas del método que destacan las condiciones en las que se desarrolla el proceso docente; el material verbal y los medios de enseñanza.

En el tercer momento, que son las conclusiones del tratamiento, se va a dar una valoración de cómo el educando trabajó durante el desarrollo de la actividad y para finalizar se le indicará la tarea, que tendrá relación con el contenido trabajado, la cual debe ser de estricto cumplimiento y los padres deben insistir en su realización.

El educando ciego con diagnóstico de dislalia funcional, durante el proceso de comunicación utiliza como recurso el lenguaje en sus diferentes formas: oral, escrito, gestual e icónico. En él es observable un déficit durante la adquisición del lenguaje como instrumento cultural, que limita su acceso a las posibilidades de interacción con su entorno y a recibir y transmitir información. Por esta razón, el proceso de intervención en el lenguaje debe contribuir a desarrollar esta herramienta deficitaria mediante ayudas especializadas, sobre la base de las potencialidades como el sistema de estructuras cognitivas y afectivas que bajo condiciones externas propicias permiten el desarrollo de la capacidad. Lo más importante en un educando con diagnóstico de ceguera es conocer más que los defectos del alumno, sus potencialidades, porque en ellas están sus posibilidades de desarrollo; por ello, la intervención logopédica debe dirigirse a su búsqueda y estimulación.

Precisión de Potencialidades y Necesidades:

El educando presenta necesidades afectivas, atención de su familia y coetáneos, por lo que en ocasiones se muestra agresivo, carece de vivencias y experiencias, aunque tiene gran imaginación, producto de esta imaginación miente en muchos aspectos dado que no conoce su todo su entorno. Es un niño muy inteligente, presenta habilidades en las matemáticas, se interesa mucho por aprender, su orientación y movilidad es muy buena, pocas veces utiliza bastón.

Técnicas psicológicas aplicadas:

Completamiento de frases.

Nombre: AMR.

Edad: 9 años.

Sexo: Masculino.

Grado: 4to.

Escuela: Abel Santamaría Cuadrado.

Instrucciones.

Completa las frases de manera que expreses tus sentimientos y opiniones.

Observaciones.

No necesitó ayuda al completar las frases existe una posible manifestación de conflicto en el cumplimiento del régimen de vida, a la hora de dormir.

Se aprecian conflictos en la familia. Su mamá no le permite salir de la casa. Expresa que su mayor temor son las pesadillas, por lo que no que no desea acostarse. Se autovalora de estudioso y bueno.

Análisis.

En el completamiento de frases prevalece el tema de la familia y la recreación.

Aspectos más significativos:

- Interés por ir a la playa.
- Conflictos en el sueño.
- Las autovaloraciones.

Presenta polaridad afectiva positiva en las siguientes frases:

- Mis amigos me buscan para jugar.
- Soy estudioso y bueno.
- El mejor jardinero es el que da agua a las plantas.
- Lamento mucho que no pueda ir a la playa.

Contenido específico de las respuestas.

Conflictos.

- relacionados con la familia.
- en el sueño.
- en la autovaloración.

Técnica de los 10 deseos.

Se le entrega una hoja en blanco y se le pide que escriba sus 10 principales deseos o aspiraciones.

Los mayores deseos dan respuesta al tema del interés por el conocimiento (deseos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10)

3 miedos.

Se reflejan dificultades en el sueño y en la relación con sus coetáneos.

3 roñas.

Que no le hagan caso, no hacer su voluntad y que lo molesten.

3 alegrías.

Relacionadas con la alimentación y con las actividades que realiza la escuela.

- **Estrategia de intervención psicopedagógica.**

Objetivo: Potenciar el desarrollo de habilidades lingüísticas y sociales en el educando con diagnóstico de discapacidad sensorial ciego

Tareas generales de la estrategia de intervención:

Área de comunicación:

- Continuar tratamiento logopédico para lograr el empleo de un lenguaje comprensivo.
- Estimular el lenguaje mediante actividades con canciones y adivinanzas.
- Realizar las tareas indicadas por la logopeda y seguimiento del desarrollo del alumno en correspondencia con el vocabulario participando en diferentes conversaciones.

Responsable:

Fecha:

Acciones:

Comportamiento social y comunitario:

- Incorporarlo en actividades dentro y fuera del hogar, así como estimular su realización.
- Participar en actividades deportivas y recreativas dentro y fuera de la comunidad.

Responsable:

Fecha:

Acciones:

Vida en el hogar:

- Desarrollar su autovalidismo mediante el cepillado, aseo, organización del puesto de trabajo y lavado de las manos, así como su participación en el taller de jardinería.
- Incorporar en las actividades en el hogar como: botar la basura, elaboración de platos sencillos, apoyo al lavado de prendas (ropa).
- Participar en actividades en el área de la comunidad.

Responsable:

Fecha:

- **Estrategia de intervención logopédica.**

Objetivo: Corregir y/o compensar la dislalia funcional en correspondencia al desarrollo de habilidades comunicativas y la personalidad del educando ciego.

Tareas:

1. Desarrollo de la motricidad articular y fina con ejercicios y praxis articulatorias.
2. Desarrollo de las cualidades del habla a través de vivencias descripción de láminas a relieves, canciones, adivinanzas, y otros recursos didácticos.
3. Desarrollo de la actividad cognoscitiva para el desarrollo de los procesos psíquicos a partir del uso de la memoria verbal como vía para el desarrollo del pensamiento y el lenguaje.
4. Trabajo y utilización del sistema Braille para la potenciación y estimulación de la comunicación.
5. Orientación a la familia para el desarrollo de la vida adulta independiente y su autovalidismo.

2.2.1 Caracterización logopédica.

Diagnóstico logopédico: Trastorno del nivel comunicativo habla asociado a una dislalia de causa funcional distorsiona los sonidos r y s con pronóstico reservado.

Teniendo en cuenta los datos concretos sobre la evolución del lenguaje; al inicio hubo omisión de primeras palabras al año, no se precisa el resto de la evolución por no recordar, la familia es potenciadora del desarrollo del lenguaje ya que ejerce una influencia en su educación, vinculados al medio social en que transcurre su vida; brindan atención y apoyo en el hogar mediante las actividades orientadas en la escuela, desarrollando habilidades y propiciando una adecuada comunicación con las personas que le rodean.

El educando no tiene muchas vivencias porque los padres no lo llevan a lugares recreativos y centros culturales, además, asisten a las reuniones de padres. En el examen específico del habla presenta pequeña dificultad en la vibración de la lengua. La audición es normal.

En la conversación espontánea se expresa mediante oraciones con contenido lógico. Es coherente en las ideas que expresa, capaz de narrar vivencias y de describir objetos y lugares.

En el estado del vocabulario y la construcción gramatical, utiliza estructuras gramaticales en su conversación espontánea y en la construcción de oraciones, el vocabulario es amplio.

En la comprensión es capaz de ejecutar órdenes, organizar secuencias lógicas de 4 o más piezas, no presenta dificultades en la comprensión de la lectura. Distorsiona el sonido /rr/ al inicio, en el medio y al final de las palabras y sustituye el sonido /s/ por /z/. En las características de la voz posee un tono medio, timbre sonoro, intensidad normal y entonación melódica. Presenta una lectura semioracional donde se pone de manifiesto su dislalia por rotacismo, no siempre realiza las pausas necesarias donde aparecen los signos de puntuación. Reconoce y clasifica estructuras gramaticales propias del grado, aplica reglas ortográficas. Se observan dificultades en la acentuación, delimita miembros de la oración, dificultades en el reconocimiento de los tiempos en que se encuentran las formas verbales. Durante la exploración logopédica cooperó y se mostró motivado.

- **Estrategia de intervención logopédica.**

Objetivo: Corregir y/o compensar la dislalia funcional en correspondencia al desarrollo de habilidades comunicativas y la personalidad del educando ciego.

Tareas:

1. Desarrollo de la motricidad articulatoria y fina con ejercicios y praxis articulatorias.
2. Desarrollo de las cualidades del habla a través de vivencias descripción de láminas a relieves, canciones, adivinanzas, y otros recursos didácticos.
3. Desarrollo de la actividad cognoscitiva para el desarrollo de los procesos psíquicos a partir del uso de la memoria verbal como vía para el desarrollo del pensamiento y el lenguaje.
4. Trabajo y utilización del sistema Braille para la potenciación y estimulación de la comunicación.
5. Orientación a la familia para el desarrollo de la vida adulta independiente y su autovalidismo.

Acciones:

1. Escuela:

- Realizar las actividades orientadas por la logopeda y otros docentes para lograr la corrección o compensación de su trastorno (dislalia funcional).
- Darle participación en las clases y motivarlo

2. Familia:

- Contribuir con la realización de los ejercicios orientados por la logopeda.
- Ofrecerle tareas hogareñas para darle participación en los quehaceres del hogar.

3. Comunidad:

- Incluirlo en las actividades que se realicen en la comunidad.

2.2.2 Sistema de tratamientos:

Figura 1: Sistema de tratamientos Anexo 5

• Tratamiento Logopédico 1

Objetivo: Automatizar /s/ en palabras que presentan este sonido, propiciando el perfeccionamiento léxico-gramatical

Método: Explicación.

Procedimientos: Observación, explicación.

Medios de enseñanza: tarjetas, láminas a relieve y audios.

Motivación: Entonar la Canción “Cinco Lobitos” Revisión de los ejercicios realizados en el aula y la casa

Introducción:

Se comienza la actividad poniéndole y tarareando la canción infantil “Cinco Lobitos”. ¿Qué sonido se escucha con marcada repetición? Se orienta el objetivo.

Desarrollo:

Se comienza con ejercicios prearticulatorios (vibración bilabial, movimientos linguales, masticación sonora).

1-Se le pondrá al escolar la canción para que escuche cada una de las palabras que presenten el sonido /s/.

2-Se le muestra una lámina que ilustra dos lobos para que realice su descripción.

3-Se le indicará identificar cada palabra con este sonido.

4-Luego se le entrega una tarjeta con el texto escrito en Braille, la logopeda realiza la lectura modelo y luego el escolar.

5-Se le pide que extraiga del texto las palabras con este sonido.

6-Dividir las palabras en sílabas y escoger dos de ellas para redactar un texto breve.

Conclusiones:

1- ¿Qué trabajamos hoy?

2- ¿Cómo te sentiste durante el tratamiento? Comentar las potencialidades del tratamiento trabajado y las sugerencias para el próximo.

Tarea:

- Busca otras canciones infantiles que conozcas que presenten el sonido /sl/.

Observaciones

-Realizó bien la división en sílabas y escritura de texto de las palabras seleccionadas.

-Respondió de manera correcta todas las actividades.

-No necesito niveles de ayuda.

Se realiza esta estructuración del sistema de tratamiento con la finalidad de corregir y compensar el trastorno dislalia funcional en un educando con discapacidad sensorial ciego, las fortalezas que tiene para su ejecución frecuencia 2 semanal con 15 minutos de duración durante el segundo periodo del curso escolar 2019-2020 con pronóstico favorable en su inserción social y educativa

Sugerencias metodológicas:

1. Cada tratamiento es continuidad del otro a trabajar, teniendo en cuenta las habilidades desarrolladas.
2. Se tiene que tener en cuenta las características del educando, sus fortalezas y debilidades que se puedan utilizar para potenciar el desarrollo de otras áreas y alcanzar mejor comunicación con sus coetáneos.

3. Tomar las vivencias como punto de partida para la potenciación del desarrollo del lenguaje.
4. La familia debe eliminar las actitudes de sobreprotección para evitar el sufrimiento del niño, y las que tienden a minimizar o ignorar el problema no hacen más que reforzar las insuficiencias en la comunicación.
5. Las situaciones comunicativas “naturales” no son suficientes para superar la dislalia. Es necesario planificar y diseñar otras situaciones, garantizando siempre el éxito del educando.
6. En cada momento, se debe partir de lo que el educando es capaz de hacer con ayuda y por sí solo.
7. La exigencia de la respuesta verbal se debe ajustar a una progresión y se mantendrá a lo largo de todo el proceso del tratamiento para aumentar su nivel comunicativo con calidad.
8. Las actividades deben realizarse de forma sistemática, en cada espacio que se muestre oportuno.

La pedagogía y la ciencia logopédica centra su atención en la actividad del niño como ente activo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a la inserción dinámica, en la búsqueda de situaciones a las interrogantes que se le plantea en la realidad y a través de las cuales va modificando su pensamiento, su accionar y su mundo interior, el niño debe ser el centro de su propio aprendizaje y el logopeda modela su lenguaje en función comunicativa ser diverso, inclusivo, oportuno. Esta concepción presupone que el niño es un ser que piensa, actúa y crea. ... “La forma de colaboración entre el niño y el adulto es el elemento central del proceso educativo” ...Vygotsky, L. S. (1979)

CONCLUSIONES

- El estudio de caso como método de investigación científica permite recopilar una información detallada sobre el individuo con el que se está trabajando a lo largo de un tiempo considerable. Además, constituye un momento importante en el proceso de diagnóstico en tanto facilita el intercambio y contrastación de toda la información obtenida en las indagaciones realizadas sobre la historia de vida del sujeto en interacción con los diferentes entornos, donde actúa y se relaciona (contextos de actuación y relación familia-escuela-comunidad, barrio, grupo de paraiguales), así como el resultado de las investigaciones de las diferentes áreas de desarrollo. Debe permitir establecer las regularidades y variabilidad de las características encontradas en correspondencia con los momentos y condiciones donde se producen o expresan.
- Con el estudio de caso realizado a un estudiante de 4to grado se pudo comprobar que presenta un trastorno del nivel comunicativo habla (dislalia funcional). Se expresa mediante oraciones con contenido lógico. Es coherente en las ideas que expresa, capaz de narrar vivencias y de describir objetos y lugares. La familia no es buena potenciadora del desarrollo del lenguaje. La audición es normal. Utiliza estructuras gramaticales en su conversación espontánea y en la construcción de oraciones. Vocabulario amplio acorde a su edad cronológica. Es capaz de ejecutar órdenes y no presenta dificultades en la comprensión de la lectura. Distorsiona el sonido /r/ al inicio, en el medio y al final de las palabras y sustituye /s/ por /z/.
- Mediante la aplicación del sistema de tratamientos logopédicos propuesto se observan avances en cuanto al desarrollo del vocabulario, ya que ha introducido nuevas palabras al componente lexical.

RECOMENDACIONES

- Profundizar en el estudio de caso como método de investigación científica
- Socializar entre la familia, la escuela y la comunidad las sugerencias dadas

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Colectivo de autores: compendio. *Lecciones de filosofía Marxista-Leninista*. Dirección de Marxismo-Leninismo. Ministerio de Educación Superior, p. 50.
2. Colectivo de autores: compendio. *Lecciones de filosofía Marxista-Leninista*. Dirección de Marxismo-Leninismo. Ob.cit., p 54
3. Ibídem, pp. 4-5.
4. Fernández Pérez de Alejo, Gudelia, Rodríguez Fleitas, Xiomara: Ob.cit., p. 32.
5. Natalia Consuegra Anaya: *Diccionario de Psicología*. Ecoe Ediciones. Segunda Edición, Bogotá, 2010. p. 248.
6. José Ferrater Mora: *Diccionario de Filosofía*. Editorial Sudamericana Buenos Aires. p. 687.
7. Fernández Pérez de Alejo, Gudelia, Rodríguez Fleitas, Xiomara. Ob.cit, p. 56.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Desarrollo psicológico del niño ciego. f/d
2. "Diccionario Larousse". Editorial Científico-Técnica. La Habana.
3. Martín, D. "Educación de niños con discapacidades visuales". Editorial Pueblo y Educación 2003.
4. García, G. "Compendio de pedagogía". Editorial Pueblo y Educación 2002.
5. Nocedo, I. "Metodología de la investigación". Ciudad de la Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación 2000.
6. Díaz Mayans, Concepción. Las referencias bibliográficas según el estilo Vancouver. Centro de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Educación Superior. La Habana, Cuba. Telf.: (537) 552371 Email: concha@reduniv.edu.cu.
7. Cobas Ochoa, Carmen Lidia y coautores. Temas logopédicos para los docentes. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
8. Carmen L. Cobas, Arturo Gayle Morejón. Atención a la diversidad del alumnado en el contexto escolar. Ministerio de Educación. La Habana
9. Educación Especial: razones, visión actual y desafíos. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba (1997).
10. Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares, MEC, España.
11. Arredondo Kassab. M.M.: La atención logopédica a escolares con trastorno de la comunicación escrita. 2013. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.
12. Cobas Ochoa, Carmen Lidia y coautores. Temas logopédicos para los docentes. Editorial Pueblo y Educación, La Habana. Cuba, 2010.
13. Deler Ferrera, Gustavo. La propuesta de acciones, ejercicios, tareas, actividades y conocimientos como resultados científicos en la investigación pedagógica. Abril de 2006. En soporte digital.

ANEXOS

Anexo 1

Guía de observación

Objetivo: observar los modos de actuación del menor en actividades que realiza diariamente en función del desarrollo del lenguaje y la socialización para potenciar su personalidad.

- Lugares que se van a observar: gabinete logopédico, salón de 5to año de vida y en el retorno al hogar.
- Conducta que manifiesta.
- Relación con sus coetáneos.
- Relación con los adultos.
- Actividades que la frustran o la motivan.

Anexo 2

Guía de Entrevista a especialistas

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la menor?
2. ¿Cómo se ha desempeñado desde que comenzó a trabajar con usted?
3. ¿Cuáles son sus potencialidades y sus necesidades?
4. ¿Cómo son las relaciones del hogar con la escuela?
5. ¿Qué acciones desde su especialidad ha desarrollado que contribuyan al desarrollo del menor?

Anexo 3

Entrevista a la familia

Cuestionario

- 1- ¿Cómo transcurrió el proceso de embarazo y parto?
- 2- ¿Cuáles son los antecedentes patológicos?
- 3- ¿Cómo transcurrió el desarrollo psicomotor y del lenguaje?
- 4- ¿Cómo fue la estimulación verbal que recibió la menor y cuáles fueron los recursos empleados?
- 5- ¿Qué actividades realiza la niña en el hogar?
- 6- ¿Cuáles son los gustos y desagradados de la menor?

- 7- ¿Cómo son las relaciones de la menor con los miembros de la familia y la comunidad?

Anexo 4

Entrevista a la maestra logopeda, maestra de aula y psicopedagoga.

1. ¿Qué conoces acerca la dislalia?
2. ¿Qué acciones realizas para el trabajo correctivo-compensatorio de los escolares con este diagnóstico?
3. ¿Cómo orientas al maestro de aula y a la familia para la atención logopédica del retraso del habla asociado a la dislalia funcional?
4. ¿Qué sugiere para mejorar la atención logopédica en estos casos?

Anexo 5

SISTEMA DE TRATAMIENTOS

Objetivos	Contenido	Actividades	Evaluación
Automatizar /r/ en palabras que presentan este sonido, propiciando el perfeccionamiento léxico-gramatical, empleando la canción: Estrellita ¿dónde estás?	Automatización de /r/	1-Se pondrá la canción para que escuche cada una de las palabras que presenten el sonido /r/. 2-Identificar cada palabra con este sonido. 3-Entrega del texto escrito en Braille. 4-Extraer del texto las palabras con este sonido. 5-Dividir los vocablos en sílabas	Bien

Ver Anexo 5		y escoger dos de ellos para redactar una oración con cada uno Tarea	
Automatizar /r/ y /s/ en palabras que presentan este sonido, propiciando el perfeccionamiento léxico-gramatical, empleando la canción: La granja de Zenón	Pronunciación /s/ /r/	1-Se pondrá la canción para que escuche cada una de las palabras que presenten el sonido /r/. 2-Identificar cada palabra con este sonido. 3-Entrega del texto escrito en Braille. 4-Extraer del texto las palabras con este sonido. 5-Buscar su significado en el diccionario 6-Dividir los vocablos en sílabas Tarea	Bien
Ver Anexo 5			

Automatizar /r/ en palabras que presentan este sonido, propiciando el perfeccionamiento léxico-gramatical, empleando la canción: Una rata Vieja	Pronunciación /r/	1-Se pondrá la canción para que escuche cada una de las palabras que presenten el sonido /r/. 2-Identificar cada palabra con este sonido. 3-Entrega del texto escrito en Braille. 4-Extraer del texto las palabras con este sonido. 5-Ordenar alfabéticamente con ayuda si necesita Tarea	Bien
Automatizar /s/ y /r/ en palabras que presentan este sonido, propiciando el perfeccionamiento léxico-gramatical, empleando la canción: Si tú tienes	Pronunciación /s/ y /r/	1-Se pondrá la canción para que escuche cada una de las palabras que presenten el sonido /r/. 2-Identificar cada palabra con este sonido. 3-Entrega de tarjetas con diferentes palabras y el escolar debe reconocer palabras con/s/ y /r/ presentes en la	Bien

		canción 4-La logopeda le entrega dos de las tarjetas para que realice oraciones con las palabras que muestran las mismas Tarea	
Pronunciar palabras mediante adivinanzas que favorezcan el desarrollo de la expresión oral.	Pronunciación /s/	1-Escucha con atención las siguientes adivinanzas y adivina que puede ser -Somos más de una y salimos con la Luna; si te pones a contarnos seguro que no contarás a más de una. Solución: Las estrellas 2-Mostrar laminas a relieve con algunos de los objetos de los que se habla en la adivinanza. 3-Entrega del texto escrito en Braille. 4-Identificar cada palabra con este sonido.	Bien

		5-Extraer del texto las palabras con este sonido. 6- Escribir una oración con dos de ellas. Tarea	
Pronunciar palabras mediante adivinanzas que favorezcan el desarrollo de la expresión oral.	Pronunciación /s/	1-Escucha con atención las siguientes adivinanzas y adivina que puede ser -Es redonda como un queso y nadie puede darle un beso. Solución: La luna 2-Entrega del texto escrito en Braille. 3-Identificar cada palabra con este sonido. 4-Extraer del texto las palabras con este sonido. 5-Redacta una oración con la palabra beso Tarea	Bien
Pronunciar palabras mediante adivinanzas que favorezcan el desarrollo de la	Pronunciación /s/	1-Escucha con atención las siguientes adivinanzas y	Bien

expresión oral.		adivina que puede ser -Con unos zapatos grandes y la cara muy pintada, soy el que te hace reír. Solución: El payaso 2-Entrega del texto escrito en Braille. 3-Identificar cada palabra con este sonido. 4-Extraer del texto las palabras con este sonido. 5-Dividir en sílabas la palabra zapatos en alta voz y dar una palmada cuando pronuncies el sonido /s/. Tarea	
Pronunciar palabras mediante adivinanzas que favorezcan el desarrollo de la expresión oral	Pronunciación /s/	1-Escucha con atención las siguientes adivinanzas y adivina que puede ser -Si lo escribes como es, soy de la selva el rey. Si lo escribes al	Bien

		revés, soy tu Papá Noel. Solución: El león 2-Entrega del texto escrito en Braille 3-Presentar una lámina a relieve con el animal del que se habla en la adivinanza. 4-Emitir el sonido onomatopéyico del león. 5-Modelar con plastilina un león con ayuda si lo necesita. 6-Entregar palabra selva en tarjetas con cada de los grafemas que la componen para que la organice Tarea	
Pronunciar palabras mediante adivinanzas que favorezcan el desarrollo de la expresión oral	Pronunciación /r/	1-Escucha con atención las siguientes adivinanzas y adivina que puede ser -Con sólo 3 colores ordeno a cada uno.	Bien

		Si todos me respetan no habrá accidente alguno. Solución: El semáforo 2-Entrega del texto escrito en Braille 3-Mostrar una lámina a relieve de un semáforo. 4-Extraer del texto las palabras que presentan el sonido /r/ 5-Dividir en sílabas las palabras extraídas 6-Mencionar los colores del semáforo Tarea	
--	--	---	--

Conclusiones Generales:

Se le realizan preguntas dirigidas a evaluar si fue productivo el tratamiento.

- 1- Motivación del escolar por las actividades en el gabinete logopédico.
- 2- Se ha ampliado el vocabulario a partir de la motivación del escolar en diferentes situaciones comunicativas (mediante canciones infantiles y adivinanzas).
- 3- Se ha mejorado la memoria táctil y verbal del escolar, como vía para el desarrollo del lenguaje.
- 4- Se ha producido un aumento en la duración de la atención en la actividad.

Trabajo con la familia:

- 1- Charla educativa con la mamá.
- 2- Escuela de padres.
- 3- Invitar a la madre a observar los tratamientos logopédicos de su hijo.
- 4- Visitar casa y comprobar el trabajo de la madre con el escolar en el hogar
- 5- Orientar a la madre sobre las actividades, tratamientos y ejercicios que se le efectúa al escolar en el centro.

Logros:

- El menor se orienta en espacio y tiempo de acorde a su edad cronológica.
- Establece mejor relación con sus coetáneos.
- Muestra buenos modales en la escuela y en la casa.
- Mantiene hábitos alimenticios correctos.
- Presenta buen desarrollo del autovalidismo.

Conocimientos:

- Nuevas canciones infantiles.
- Animales
- Adivinanzas

Motivación:

- Le motivan mucho los juegos.
- Las canciones infantiles.
- La música bailable.
- Los títeres.
- Las adivinanzas.

Evaluación del sistema de tratamiento aplicado: Bastante adecuado porque el educando manifestó interés en cada sesión, realizó sus tareas para conocer sobre qué trataría el siguiente tratamiento, se mostró muy motivado y entusiasmado. El objetivo propuesto inicialmente se cumplió.